

Incontinencia urinaria de esfuerzo — Hombres

Información para el paciente · Escape después de la cirugía de próstata — con esfuerzo o actividad

WARWIKI

La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en los hombres significa escapar orina cuando algo ejerce presión repentina sobre la vejiga — al toser, ponerse de pie, levantar peso o hacer actividad. En los hombres casi siempre se debe al debilitamiento del músculo que controla la orina (el esfínter) después de una **cirugía de próstata** o radiación. A menudo mejora durante el primer año y, cuando no lo hace, hay tratamientos muy eficaces disponibles.

Acerca de esta afección

Después de extirpar la próstata, el **esfínter urinario** principal (la válvula que retiene la orina) hace la mayor parte del trabajo, y puede quedar debilitado. El resultado es escape con el esfuerzo — desde unas pocas gotas que requieren una toalla, hasta un escape más abundante. Esto es diferente del escape de **urgencia** (una necesidad repentina de orinar), que se trata de otra manera; algunos hombres tienen ambos.

Qué la causa

- **Prostatectomía radical** (extirpación de la próstata por cáncer) — la causa más común
- Otros procedimientos de próstata o **radiación pélvica**
- Con menos frecuencia, problemas de los nervios o de la vejiga

El escape suele ser **peor al principio** y mejora a lo largo de semanas a meses, a medida que la cicatrización avanza y vuelve la fuerza del suelo pélvico.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escapar orina con la presión — al toser, ponerse de pie o levantar peso.

Esfínter

La válvula muscular que retiene la orina hasta que usted decide orinar.

Prostatectomía

Cirugía para extirpar la próstata, la causa habitual de la IUE en los hombres.

Suelo pélvico

Los músculos que usted ejercita para ayudar a controlar la orina.

Prueba de toallas

Contar las toallas que usa por día para medir cuánto escapa.

Cabestrillo masculino

Un soporte colocado debajo de la uretra para el escape leve a moderado.

Balones ProACT

Dos balones ajustables junto a la uretra, regulados en el consultorio; una opción mínimamente invasiva.

Esfínter urinario artificial

Un dispositivo implantado (un manguito que usted controla) para el escape moderado a severo.

¿MEJORARÁ POR SÍ SOLA? A menudo, sí — el escape después de la cirugía de próstata suele mejorar durante los primeros 6–12 meses, sobre todo con ejercicios del suelo pélvico. Si un escape molesto persiste más allá de aproximadamente un año, ese es el momento de considerar un cabestrillo, balones ajustables o un esfínter artificial — todos los cuales funcionan muy bien.

Cómo se diagnostica

- Una conversación sobre cuándo y cuánto escapa (a menudo contado como **toallas por día**)
- Un **análisis de orina** y una comprobación de qué tan bien vacía la vejiga
- Antes de la cirugía: una mirada dentro de la uretra (cistoscopia) y a veces pruebas de la función de la vejiga

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 **Ejercicios del suelo pélvico** (ejercicios de Kegel), idealmente comenzados alrededor del momento de la cirugía, además de controlar los líquidos y el peso.
- 2 **Mejoría con observación** durante el primer año, usando toallas o protección según sea necesario.
- 3 **Cabestrillo masculino** — para el escape leve a moderado persistente (no requiere otra operación después).
- 4 **Balones ajustables ProACT** — otra opción mínimamente invasiva para el escape leve a moderado; dos balones pequeños se regulan en el consultorio a lo largo de varias visitas (no se usan después de la radiación).
- 5 **Esfínter urinario artificial (EUA)** — el patrón de referencia para el escape moderado a severo, y la opción después de la radiación. Cada uno tiene su propia hoja informativa.

Vivir con la IUE en los hombres

- Haga los ejercicios del suelo pélvico de forma constante — son la base.
- Use toallas o una prenda protectora para tener confianza mientras se recupera.
- Limite los líquidos y la cafeína por la noche si el escape nocturno es un problema.

Llame a su equipo si tiene:

- Ardor, fiebre o **sangre en la orina** (posible infección)
- De repente **no puede orinar**
- Escape que empeora en lugar de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La IUE en los hombres casi siempre se debe a un esfínter debilitado después de la cirugía de próstata o la radiación — y suele mejorar durante el primer año.
2. Los ejercicios del suelo pélvico son la base; para el escape duradero, un cabestrillo masculino o un esfínter urinario artificial funcionan muy bien.
3. Dé hasta un año a la recuperación antes de decidir operarse. Llame si tiene fiebre, sangre en la orina o no puede orinar.